ПРИКАЗЫ И ПИСЬМА В ИЗЛОЖЕНИИ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Оспа обезьян

Мрох (MPXV): клады вируса, период заразности до симптомов, эпидемиологический анамнез и противоэпидемический режим

Источник: информационное письмо ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы № 1-14/2680 от 30.08.2024.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 11 октября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

О чём письмо

Письмо издано по письму Министерства здравоохранения РФ от 24.08.2024 № 30-4/И/2-16470: 14.08.2024 генеральный директор ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в связи с распространением вируса оспы обезьян.

Для бригады операционное правило то же, что для других конвенционных инфекций: **у пациента с лихорадкой и сыпью собирается эпидемиологический анамнез — выезды за пределы страны; при подозрении на оспу обезьян действует приказ Станции № 2710 от 10.11.2023 о санитарной охране территории.**

Оспа обезьян как болезнь

Оспа обезьян (mpox, MPXV) — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом рода ортопоксвирусов. Природный резервуар вируса находится в ряде стран Центральной и Западной Африки.

Существуют две генетические клады вируса: центральноафриканская (бассейн Конго, клада I) и западноафриканская (клада II). Клада I считается более заразной и вызывает более тяжёлое заболевание с более высокой смертностью; глобальная вспышка 2022 года была вызвана вирусом клады IIb с менее тяжёлым течением.

Передача происходит при прямом контакте с кровью, биологическими жидкостями, поражённой кожей или слизистыми инфицированных животных, а также воздушно-капельным путём при длительном личном контакте. Во вспышке 2022 года в Европе и других странах вирус передавался между людьми преимущественно половым путём.

Эпидемиологическая ситуация

С конца 2023 года зарегистрирована крупная вспышка в Демократической Республике Конго, вызванная вирусом клады I; на момент письма вирус распространяется также в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.

Клиническая картина

Инкубационный период составляет 6–21 день (по письму — в диапазоне 5–21 день). Существенная операционная особенность: **пациент считается заразным за 3 дня до появления клинических симптомов.**

Начальный период (0–5-й день): лихорадка, лимфаденопатия, сильная головная боль, миалгия, астения. Через 1–3 дня после появления лихорадки возникают высыпания на лице, коже ладоней и ступней, слизистых полости рта и гениталиях; элементы постепенно трансформируются в пустулы и покрываются корочкой.

Элементы сыпи проходят последовательные стадии: пятно, папула, везикула, пустула с пупковидным вдавлением в центре, изъязвление, корочка (рис. 1). Элементы плотные, глубоко расположенные, в классическом течении в пределах одной области находятся преимущественно на одной стадии развития и характерно поражают ладони и подошвы (рис. 2).



Рис. 1. Стадии развития элемента при оспе обезьян. Верхний ряд: ранняя везикула (3 мм), мелкая пустула (2 мм), пустула с пупковидным вдавлением (3–4 мм). Нижний ряд: изъязвившийся элемент (5 мм), образование корочки на зрелом элементе, частично отделившаяся корочка. UK Health Security Agency (O. O. Afuye, 2019), Wikimedia Commons, Open Government Licence 3.0.



Рис. 2. Элементы сыпи на ладонях пациента при вспышке оспы обезьян в Демократической Республике Конго (1997): пустулы и корочки на одной стадии развития. Фото: CDC / B. W. J. Mahy, Wikimedia Commons, общественное достояние.

Дифференциальная диагностика проводится с экзантемными заболеваниями: ветряной оспой, корью, сифилисом и медикаментозной аллергией. Лимфаденопатия и локализация элементов на ладонях и ступнях — признаки, отграничивающие трох от ветряной оспы.

Что предписано бригаде и диспетчерской

Кому	Предписание
Единая городская диспетчерская	При оформлении вызова к пациенту с лихорадкой, ознобом, миалгией и сыпью, характерной для оспы обезьян, уточнять у вызывающего выезд пациента в зарубежные страны и вносить сведения в приложение к вызову
Выездной персонал	Тщательный и детальный сбор эпидемиологического анамнеза у больных, прибывших из эпидемически неблагополучных по оспе обезьян стран
Заведующие и старшие врачи	При выявлении больного с подозрением на оспу обезьян обеспечить соблюдение приказа № 2710 от 10.11.2023; довести письмо до персонала

Действия при подозрении

Подозрение формируется сочетанием: лихорадка с лимфаденопатией и характерной сыпью (лицо, ладони, ступни, слизистые, гениталии) **плюс** пребывание в эндемичном регионе в пределах инкубационного периода — до 21 суток, что задаёт необычно глубокий эпидемиологический анамнез.

При подозрении включается противоэпидемический режим приказа № 2710: работа в средствах индивидуальной защиты, изоляция пациента, дезинфекция, уведомление старшего врача смены и госпитализация в стационар инфекционного профиля.

Предписания письма

- ЕГДЦ уточняет выезд за рубеж при вызовах с лихорадкой, ознобом, миалгией и сыпью и вносит сведения в приложение к вызову.
- Выездной персонал собирает эпидемиологический анамнез у прибывших из неблагополучных стран.
- При подозрении — неукоснительное соблюдение приказа № 2710 от 10.11.2023.
- Письмо доводится до сведения персонала подразделений.

Источники

- Информационное письмо ГБУЗ «ССиНМП им. А. С. Пучкова» ДЗМ № 1-14/2680 от 30.08.2024.
- Письмо Министерства здравоохранения РФ от 24.08.2024 № 30-4/И/2-16470.
- Приказ ССиНМП им. А. С. Пучкова № 2710 от 10.11.2023 «Об обеспечении мероприятий по предупреждению заноса и распространения инфекционных (паразитарных) болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории города Москвы».

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник
`images/stadii_elementov.jpg`	Стадии развития элемента сыпи	Wikimedia Commons, «Stages of monkeypox lesion development.jpg», UK government (O. O. Afuye), Open Government Licence 3.0
`images/ladoni.jpg`	Сыпь на ладонях	Wikimedia Commons, «Monkeypox 12761.jpg», CDC / Brian W. J. Mahy, общественное достояние

Выходные данные

Оспа обезьян · версия 1.1 · октябрь 2026 · Серия «Крещение поворотом» · CC BY-NC-SA 4.0. Материал носит справочный характер и не заменяет действующие приказы и клинические рекомендации.

Нашли ошибку — напишите в «Обсуждениях» репозитория на GitHub.